中成药治疗儿童流感临床应用指南（2024年）

中国标准化协会中医药标准化分会

［摘要］ 儿童是流感的高发人群，中成药在治疗儿童流感中具有明显优势。为指导临床医生合理使用中成药，以“循证为基、临床为重”为总原则，采用临床和方法学专家双牵头模式制定了一部具有科学性和临床适用性的指南。指南依据“三特”原则构建临床问题，系统检索、筛选和整合相关临床疗效和应用证据，并使用GRADE方法对证据进行分级。结合患者偏好、药物经济性等因素，通过共识会议形成推荐意见，最终推荐了13个中成药。

［关键词］ 流感；儿童；中成药；指南

流行性感冒（以下简称流感）是流感病毒引起的急性呼吸道传染病，甲型和乙型流感病毒呈季节性流行[1]。中医将流感归为“外感热病”“时行感冒”等范畴[2]，认为其主要诱因是感受外邪，正邪交争，从而引起机体阴阳失调，导致发热、恶寒、全身酸痛等症状[3]。儿童是流感的高发和重症高危人群，儿童流感发病率可达到20%~30%[4]。风热犯卫证、表寒里热证、热毒袭肺证等是儿童流感的常见证型[1]。西医治疗流感主要依赖奥司他韦、玛巴洛沙韦等抗病毒药物[1]，但许多患者已出现了耐药现象[5]。中成药治疗儿童流感具有抗病毒、解热镇痛和调节免疫功能等优势，且不良反应小，耐药性低[6]。但是，中成药在儿童流感治疗中的应用仍缺乏规范指导，尤其对于缺乏系统中医理论培训的西医医师，中成药使用不当可能导致疗效不佳并增加不良反应。因此，需制定符合循证医学原则的指南来进一步指导临床医生合理使用中成药治疗儿童流感。

《中成药治疗儿童流感临床应用指南（2024年）》（以下简称本指南）以“循证为基、临床为重”为总原则，采用临床和方法学专家双牵头的工作模式，充分保证指南的科学性和临床适用性。指南制定程序参考中成药临床实践指南系列规范[7-13]，依据“三特”原则（即特定中成药、特定疾病阶段、特定结局）构建临床问题[9]，系统检索、筛选、整合中成药相关临床疗效证据和应用证据，使用推荐意见分级的评估、制订及评价方法（Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE）对证据体进行分级[14]，结合患者偏好和价值观、药物经济性等因素形成证据概要表，通过共识会议最终确定各临床问题的推荐意见及其强度，以指导临床合理使用中成药。指南的制定方法和步骤请见附件1。

本指南在国际实践指南注册与透明化平台（pactice guideline registration for transparency, PREPARE）进行注册（注册号：IPGRP-2022CN087）。

1 指南的范围

本指南主要应用于18岁及以下确诊为流感的儿童患者[15]。本指南主要适用于西医执业医师和基层医生。

2 推荐意见

本指南共推荐了13个中成药，其中小儿豉翘清热颗粒、小儿青翘颗粒、小儿柴桂退热颗粒和芩香清解口服液为本指南强推荐的4个中成药；小儿热速清颗粒（糖浆、口服液）、抗感颗粒、开喉剑喷雾剂（儿童型）、小儿双金清热口服液、蒲地蓝消炎口服液、小儿牛黄清心散、热毒宁注射液、喜炎平注射液和小儿肺咳颗粒为本指南弱推荐的9个

基金项目：国家自然科学基金（82105053）；中国中医科学院科技创新工程项目（CI2022C004-01，CI2021A05505）；中央级公益性科研院所基本科研业务费专项（ZZ14-YQ-039）；国家中医药管理局青年岐黄学者项目（Z0841）；中华中医药学会青年人才托举工程项目（2024-QNRC2-B41）

中成药。13个中成药的推荐意见总结请见附件2、3、4。

本指南中13个中成药推荐意见的撰写规范参照《中成药临床实践指南报告清单V1.0》[12]，包括用药指征（特定阶段、特定人群、特定结局、证据描述）、给药方式（给药途径、药剂使用特点）、给药频次和疗程（用量及频次、给药时间、给药疗程）、联合用药（协同用药、禁忌用药）、食疗配伍（食疗调护、饮食禁忌）、停药指征（停药时机、停用方法）、不良反应及其处理措施、给药禁忌（禁忌症、慎用症）、用药提示（监测指标、药品贮藏）和参考事项（药物组成、说明书适应症、药物经济学、国家政策、药理作用）。每个中成药的推荐理由、证据描述及药理作用信息见附件5。儿童流感的诊断及辨证分型具体内容见附件6。

2.1　小儿豉翘清热颗粒

推荐小儿豉翘清热颗粒[16-30]用于流感患儿，临床表现为发热、咳嗽、鼻塞流涕、咽痛、纳呆、腹胀、便秘者。（GRADE证据等级：B；强推荐）

药物组成：连翘、淡豆豉、薄荷、荆芥、炒栀子、大黄、青蒿、赤芍、槟榔、厚朴、黄芩、半夏、柴胡、甘草。（说明书）

使用要点：饭后服用，每日3次，开水冲服。6个月至1岁，每次1~2 g；1至3岁，每次2~3 g；4至6岁，每次3~4 g；7至9岁，每次4~5 g；10岁及以上，每次6 g。（说明书）。可搭配生姜白糖水或适量大米粥增加疗效，不建议为改善口感而加入牛奶、饮料等矫味剂同时服用。（专家共识）

热退24小时后可考虑停药，若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议重新评估病情，并考虑更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中若疗效欠佳或患儿症状明显者，可与布洛芬联用，联合药物用法用量参照说明书，建议与中成药服用间隔半小时。该药含有半夏，不建议与含有乌头类的药物同时使用；慎与滋阴补虚类的药物同时服用。（专家共识）

注意事项：对本品及所含成分过敏的患儿禁用；平素脾胃虚弱、大便溏稀患儿慎用。该药的不良反应包括腹泻、恶心、呕吐、腹痛、腹部不适、皮疹、瘙痒、荨麻疹、过敏反应等，若出现不良反应，应暂停服用本品。该药常温贮藏即可。（说明书和专家共识）

2.2　小儿青翘颗粒

推荐小儿青翘颗粒[31]用于流感患儿，临床表现为恶寒发热、咽干、咽痛、咽部灼热者。（GRADE证据等级：B；强推荐）

药物组成：金银花、连翘、葛根、大青叶、山豆根、柴胡、甘草。（说明书）

使用要点：饭后服用，开水冲服。1至4岁，每次5 g，每日3次[31]；5至7岁，每次7.5 g，每日3次；8至10岁，每次7.5 g，每日4次；11至14岁，每次10 g，每日3次。（说明书和专家共识）

不建议为改善口感而加入牛奶、饮料等矫味剂同时服用。（专家共识）

热退24小时后可考虑停药，若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议重新评估病情，并考虑更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中若疗效欠佳或患儿症状明显者，可与布洛芬或对乙酰氨基酚联用，联合药物用法用量参照说明书，建议与中成药服用间隔半小时。该药不建议与相同或相似功效的解表药同时使用。（专家共识）

注意事项：原发性/特发性粒细胞减少症、原发性/特发性白细胞减少症者忌用；葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症慎用，体弱多汗的患儿慎用；该药的不良反应包括腹痛、便稀、恶心、呕吐等，若出现这些不良反应，应停药。该药常温贮藏即可。（说明书和专家共识）

2.3　芩香清解口服液

推荐芩香清解口服液[32]用于流感患儿，临床表现为发热、咳嗽、鼻塞、流涕、咽红肿痛、便秘、口渴烦躁、舌红苔黄、脉滑数者。（GRADE证据等级：B；强推荐）

药物组成：黄芩、广藿香、蝉蜕、石膏、葛根、大黄、赤芍、板蓝根、桔梗、玄参、山豆根、甘草。（说明书）

使用要点：饭后服用，不建议加水稀释。6个月至3岁，每次5 mL；3至7岁，每次10 mL；7至14岁，每次15 mL。每日3次。（说明书和专家共识）

不建议为改善口感而加入牛奶、饮料等矫味剂同时服用。（专家共识）

热退24小时后可考虑停药，若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议重新评估病情，考虑更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中若疗效欠佳或患儿症状明显者，可与布洛芬或对乙酰氨基酚联用，联合药物用法用量参照说明书，建议与中成药服用间隔半小时。该药不建议与补益药及含有相同成分的解表药同时使用。（专家共识）

注意事项：对本品及所含成分过敏者禁用,6个月

以下的患儿无用药经验，脾虚便溏等患儿不建议使用。该药的不良反应包括轻度呕吐、腹泻，若出现这些不良反应，应停药。该药常温贮藏即可。（说明书和专家共识）

2.4　小儿柴桂退热颗粒

推荐小儿柴桂退热颗粒[33-34]用于流感患儿，临床表现为发热、头身痛、流涕、咽红、口渴、溲黄、便干者。（GRADE证据等级：C；强推荐）

药物组成：柴胡、桂枝、葛根、浮萍、黄芩、白芍、蝉蜕。（说明书）

使用要点：饭前服用，开水冲服。1岁以内，每次0.5袋；1至3岁，每次1袋；4至6岁，每次1.5袋；7至14岁，每次2袋；每日4次；3天为一疗程。（说明书和专家共识）可搭配热稀粥增加疗效，不建议为改善口感而加入牛奶、饮料等矫味剂同时服用。（专家共识）

热退24小时可考虑停药；若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议重新评估病情，考虑更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中若疗效欠佳或患儿症状明显者，可与奥司他韦联用，联合药物用法用量参照说明书，建议与中成药服用间隔半小时。该药含有白芍，在使用过程中不建议与含有藜芦的中成药联用。（专家共识）

注意事项：对本品及所含成分过敏患儿禁用该药；过敏体质患儿慎用该药。该药的不良反应包括腹泻、皮疹、瘙痒、恶心、呕吐，若出现这些不良反应，应立即停药。该药需在常温、干燥环境下贮藏。（说明书和专家共识）

2.5　小儿热速清颗粒（糖浆、口服液）

推荐小儿热速清颗粒（糖浆、口服液）[35-43]用于流感患儿，临床表现为高热、咳嗽、鼻塞流涕、咽喉肿痛、头痛、大便干结者。（GRADE证据等级：B；弱推荐）

药物组成：柴胡、黄芩、板蓝根、葛根、金银花、水牛角、连翘、大黄。（说明书）

使用要点：饭后服用，颗粒剂温水冲服，糖浆剂、口服液可加温水稀释。颗粒剂：1岁以内，每次0.25袋~0.5袋；1至3岁，每次0.5~1袋；3至7岁，每次1袋~1.5袋；7至12岁，每次1.5~2袋；每日3或4次。口服液：1岁以内，每次2.5~5 mL；1至3岁，每次5~10 mL；3至7岁，每次10~15 mL；7至12岁，每次15~20 mL；每日3或4次。糖浆剂：1岁以内，每次2.5~5 mL；1至3岁，每次5~10 mL；3至7岁，每次10~15 mL；7至12岁，每次15~20 mL；每日3或4次。（说明书和专家共识）

不建议为改善口感而加入牛奶、饮料等矫味剂同时服用。（专家共识）

热退24小时后可考虑停药，若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议重新评估病情，考虑更换药物。为进一步缓解症状，在使用过程中若疗效欠佳或患儿症状明显者，可与奥司他韦联用，联合药物用法用量参照说明书，建议与中成药服用间隔半小时。不建议与滋补性中药同时服用。（专家共识）

注意事项：风寒感冒，大便次数多者，对本品过敏患儿禁用该药；过敏体质及葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者慎用该药。服用该药期间可能会有皮疹、瘙痒、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头痛、头晕等不良反应，若出现这些不良反应，应对症治疗。该药常温贮藏即可。（说明书和专家共识）

2.6　蒲地蓝消炎口服液

推荐蒲地蓝消炎口服液[44-48]用于流感患儿，临床表现为发热、咽痛者。（GRADE证据等级：B；弱推荐）

药物组成：蒲公英、苦地丁、板蓝根、黄芩。（说明书）

使用要点：饭后服用，不建议加水稀释。每次10 mL（相当于饮片10.01 g），每日3次。儿童酌减。（说明书和专家共识）

可搭配小米粥、大米粥服用，从而缓解部分患儿的服药不适感；也可加入矫味剂（如白糖、牛奶、饮料）同时服用。（专家共识）

热退24小时后可考虑停药，若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议复查，考虑更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中可与奥司他韦联用，联合药物用法用量参照说明书，建议与中成药服用间隔半小时。慎与多种相同或相似功效的药物同时使用，慎与滋补药同时使用。（专家共识）

注意事项：对本品及所含成分过敏的患儿禁用该药；症见腹痛、喜暖、泄泻等脾胃虚寒者、过敏体质者及葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者慎用该药。该药的不良反应包括恶心、呕吐、腹胀、腹痛、腹泻、乏力、头晕等，以及皮疹、瘙痒等过敏反应，若出现这些不良反应，应停药，多饮水强化代谢，大部分症状即可消失；如症状未能缓解建议联系医生进一步诊治。该药常温贮藏即可。（说明书和专家共识）

2.7　小儿牛黄清心散

推荐小儿牛黄清心散[49-56]用于流感患儿，临

床表现为高热、咳喘、抽搐者（GRADE证据等级：B；弱推荐）。

药物组成：天麻、胆南星、黄连、赤芍、大黄、全蝎、水牛角浓缩粉、僵蚕（麸炒）、体外培育牛黄、琥珀、雄黄、冰片、朱砂、金礞石（煅）。（说明书）

使用要点：饭后服用，温水冲服。1岁以内，每次1袋；1至3岁，每次2袋；3岁以上酌增；每日1或2次。（说明书和专家共识）

可搭配热稀粥缓解服药后反应，不建议为改善口感而加入牛奶、饮料等矫味剂同时服用。（专家共识）

热退24小时后可考虑停药，若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议重新评估病情，考虑更换药物；若患儿有抽搐症状，服用该药后未即刻缓解，也建议更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中可与奥司他韦联用，联合药物用法用量参照说明书，与中成药服用间隔半小时。慎与具有相同或相似功效的清热化痰、镇惊止痉及通腑泻下药联用。（专家共识）

注意事项：风寒感冒，痘疹期间引起的发热患儿禁用该药。该药常温贮存即可。（专家共识）

2.8 抗感颗粒

推荐抗感颗粒[57-62]用于流感患儿，临床表现为发热、鼻塞、喷嚏、咽痛、头痛、全身乏力酸痛者。（GRADE证据等级：C；弱推荐）

药物组成：金银花、赤芍、绵马贯众。（说明书）

使用要点：饭后服用，开水冲服。1至5岁，每次2.5 g；6至9岁，每次5 g；10至14岁，每次7.5 g；15岁以上，每次10 g。每日3次。（说明书和专家共识）

可搭配热稀粥增加疗效，不建议为改善口感而加入牛奶、饮料等矫味剂同时服用。（专家共识）

热退24小时后可考虑停药，若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议重新评估病情，考虑更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中若疗效欠佳或患儿症状明显者，可与布洛芬混悬液或解热药物（腋温＞38.5 ℃时）、奥司他韦联用，联合药物用法用量参照说明书，建议与中成药服用间隔半小时。不建议与含有黎芦的中药方剂或成药同时服用。（专家共识）

注意事项：对本品及所含成分过敏者禁用；脾虚便溏者慎用；过敏体质者慎用。本品可见以下不良反应：恶心、呕吐、腹胀、腹痛、腹泻等消化系统症状，皮疹、瘙痒、荨麻疹、斑丘疹等过敏反应，若出现这些不良反应应立即停药。该药常温贮藏即可。（说明书和专家共识）

2.9 开喉剑喷雾剂（儿童型）

推荐开喉剑喷雾剂（儿童型）用于流感患儿，临床表现为咽部不适、咽喉肿痛者。（弱推荐）

药物组成：八爪金龙、山豆根、蝉蜕、薄荷脑。（说明书）

使用要点：饭前饭后均可使用，喷患处，每次适量，每日数次。用药后不可立即饮水，建议半小时后可饮水。（说明书和专家共识）

咽部不适、咽喉肿痛消失后可考虑停药，若治疗3天后咽喉肿痛症状未缓解或加重则建议重新评估病情，考虑更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中若疗效欠佳或患儿症状明显者，可与奥司他韦联用，联合药物用法用量参照说明书，建议与中成药服用间隔半小时。不建议与组成功效相同或相似的中药联用。（专家共识）

注意事项：对本品过敏者禁用，酒精过敏者及过敏体质者慎用，心肺功能不全或肝肾损伤者慎用。偶见轻度恶心、呕吐，一般可自行缓解；罕见过敏反应如皮疹、瘙痒，停药后可自行消退。服药后出现腹泻、腹痛等不适者应停服。该药置阴凉干燥处（不超过20 ℃）贮藏。（说明书和专家共识）

2.10 小儿双金清热口服液

推荐小儿双金清热口服液[63-65]用于流感患儿，临床表现为低热、咳嗽、咽红者。（GRADE证据等级：C；弱推荐）

药物组成：金银花、蒲公英、大青叶、板蓝根、赤芍、柴胡、秦艽、荆芥、淡竹叶、莱菔子、桔梗、苦杏仁、僵蚕、广藿香、石菖蒲、郁金。（说明书）

使用要点：饭后服用，可加温水稀释。每次10~20 mL，每日3次。（说明书和专家共识）

不建议为改善口感而加入牛奶、饮料等矫味剂同时服用。（专家共识）

热退24小时后可考虑停药，若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议重新评估病情，并考虑更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中若疗效欠佳或患儿症状明显者，可与奥司他韦联用，联合药物用法用量参考药品说明书，建议与中成药服用间隔半小时。慎与滋补药物同时服用。（专家共识）

注意事项：外感高热者患者，对本品过敏者，及葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患儿禁用该药；脾虚易腹泻者，过敏体质患儿慎用该药。该药的不良反应尚不明确，与奥司他韦联用时，可能出现头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、皮疹等不良反应，若出现，应暂停用药，轻症观察，不缓解者及时去医院就诊。该药常温贮藏即可。（说明书和专家共识）

2.11 热毒宁注射液

推荐热毒宁注射液[66-68]用于流感患儿，临床表现为高热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头身疼痛者。（GRADE证据等级：C；弱推荐）

药物组成：青蒿、金银花、栀子。（说明书）

使用要点：静脉滴注，稀释液为5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液。3至5岁，最高剂量不超过10 mL，稀释液50~100 mL，滴速30~40滴/分钟；6至10岁，每次10mL，稀释液100~200 mL，滴速30~60滴/分钟；11至13岁，每次15 mL，稀释液200~250 mL，滴速30~60滴/分钟；14至17岁，每次20 mL，稀释液250 mL，滴速30~60滴/分钟；每日1次。本品使用后需用5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液冲洗输液管后，方可使用下一种药物。（说明书）

热退24小时后可考虑停药，若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议重新评估病情，考虑更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中可与奥司他韦联用，联合药物用法用量参照说明书。慎与疗效相同或相似的注射液联用。（专家共识）

注意事项：对本品或含有青蒿、金银花、栀子制剂及成分中所列辅料过敏或有严重不良反应病史者禁用，2岁以下患儿禁用，过敏体质、既往有溶血反应（血胆红素轻度增高或尿胆原阳性）发生患儿慎用该药。该药的不良反应包括过敏或过敏样反应、全身反应、皮肤症状、呼吸系统症状、精神及神经系统症状、消化系统症状、用药部位症状等。若出现这些不良反应，应立即停药，并对症治疗。用药后定期监测血总胆红素和直接胆红素。（说明书和专家共识）

2.12 喜炎平注射液

推荐喜炎平注射液[69-71]用于流感患儿，临床表现为高热、咳嗽、咽干咽痛、头身疼痛、腹泻者。（GRADE证据等级：C；弱推荐）

药物组成：穿心莲内酯总磺化物。（说明书）

使用要点：静脉滴注，稀释液为5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液。每日按体重5~10 mg/kg（0.2~0.4 mL/kg），最高剂量不超过250 mg，100~250 mL稀释液，控制滴速每分钟30~40滴，每日1次；或遵医嘱。（说明书）

热退24小时后可考虑停药，若治疗3天后发热症状未缓解或加重则建议重新评估病情，考虑更换药物。此外，为进一步缓解症状，在使用过程中可与奥司他韦联用，如体温超过38.5 ℃时可与布洛芬或对乙酰氨基酚联用，联合药物用法用量参照说明书，禁止与其他穿心莲制剂联合使用。如确需要联合使用其他药品时，应谨慎考虑与本品的间隔时间，在换药时建议冲洗输液管，以防药物相互作用。（专家共识）

注意事项：对本品所含成分过敏或有严重不良反应病史者禁用，流感轻症、1岁以下患儿禁用该药，1~2岁以下幼儿使用本品应慎重。该药的不良反应包括过敏反应、皮肤及其附件症状、全身性症状、消化系统症状、呼吸系统症状、心血管系统症状、神经精神系统症状、用药部位症状。若出现这些不良反应，应立即停药，并对症处理。（说明书和专家共识）

2.13 小儿肺咳颗粒

推荐小儿肺咳颗粒[72-73]用于流感患儿，临床表现为咳嗽痰多、咳吐不爽、气短、乏力、喘促、汗多、纳差、舌红苔厚者。（GRADE证据等级：C；弱推荐）

药物组成：人参、茯苓、白术、陈皮、鸡内金、酒大黄、鳖甲、地骨皮、北沙参、炙甘草、青蒿、麦冬、桂枝、干姜、淡附片、瓜蒌、款冬花、紫菀、桑白皮、胆南星、黄芪、枸杞子。（说明书）

使用要点：饭后半小时服用，开水冲服。1岁以下，每次2 g；1至4岁，每次3 g；5至8岁，每次6 g；每日3次。（说明书和专家共识）

可搭配山药、薏米、陈皮等食疗方式增加疗效，不建议为改善口感而加入牛奶、饮料等矫味剂同时服用。（专家共识）

止咳后可考虑停药，若治疗3天后咳嗽症状未缓解或加重则建议复查，考虑更换药物。不建议与含有乌头的中成药联用。（专家共识）

注意事项：发热期（急性期）患儿禁用该药，咳嗽剧烈、咽喉肿痛患儿慎用该药。该药的不良反应可能包括呕吐（喂药不当），若出现不良反应，应停止喂药，过4~6小时后，加白糖等矫味剂后再次尝试，如仍服药困难，应换药。该药常温贮存即可。（说明书和专家共识）

利益冲突声明

指南工作组成员均已填写利益冲突声明表，且均无相关的商业、专业及其他方面的利益冲突。

指南制定参与人员

指南指导委员会：王燕平（中国中医科学院中医临床基础医学研究所）、熊磊（云南中医药大学）、马融（天津中医药大学第一附属医院）。

指南临床专家组（按姓氏拼音排序）：常克（成都中医药大学附属医院）、陈华（浙江中医药大学）、冯晓纯（长春中医药大学附属医院）、高建（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心）、高修安（广东省佛山市妇幼保健院）、李继君（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心）、李敏（首都医科大学附属北京中医医院）、李新民（天津中医药大学第一附属医院）、马融（天津中医药大学第一附属医院）、明溪（云南中医药大学第一附属医院）、秦艳虹（山西中医药大学附属医院）、任献青（河南中医药大学第一附属医院）、桑杲（杭州市儿童医院）、孙丽平（长春中医药大学附属医院）、孙远岭（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心）、王波（中国中医科学院广安门医院）、王力宁（广西中医药大学第一附属医院）、王孟清（湖南中医药大学第一附属医院）、王素梅（北京中医药大学东方医院）、王晓（山东中医药大学附属医院）、王雪峰（辽宁中医药大学附属医院）、王有鹏（黑龙江中医药大学附属第二医院）、吴力群（北京中医药大学东方医院）、吴振起（辽宁中医药大学附属医院）、熊磊（云南中医药大学）、薛征（上海市中医医院）、虞坚尔（上海市中医医院）、张葆青（山东省中医院）、张霞（河南中医药大学第一附属医院）、张秀英（辽宁中医药大学附属医院）、赵霞（南京中医药大学）。

指南方法学组：梁宁、胡紫腾、晏利姣、张钰菁、陈雅馨、杨一玖、张雪飞、赵国桢、张海力、李慧珍、车前子、刘斌、郭敬（中国中医科学院中医临床基础医学研究所）。

执笔人：史楠楠（中国中医科学院中医临床基础医学研究所）[△✉]、熊磊（云南中医药大学）[△]、马融（天津中医药大学第一附属医院）[△]、胡紫腾（中国中医科学院中医临床基础医学研究所）、梁宁（中国中医科学院中医临床基础医学研究所）、明溪（云南中医药大学第一附属医院）、王雪峰（辽宁中医药大学附属医院）、张秀英（辽宁中医药大学附属医院）、孙远岭（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心）、张葆青（山东省中医院）、任献青（河南中医药大学第一附属医院）、吴振起（辽宁中医药大学附属医院）、张霞（河南中医药大学第一附属医院）。

△ 同等贡献

✉ 通讯作者：13811839164@vip.126.com

参考文献

[1]国家卫生健康委办公厅，国家中医药管理局办公室. 流行性感冒诊疗方案(2020年版)[J]. 中国病毒病杂志，2021，11(1)：1-5.

[2]王上. 基于自噬途径研究小柴胡汤对甲型流行性感冒的干预作用[D]. 武汉：湖北中医药大学，2021.

[3]敬岳. 流行性感冒中医证候学特征横断面调查及随访研究[D]. 北京：北京中医药大学，2017.

[4]Committee On Infectious Diseases. Recommendations for prevention and control of influenza in children，2021-2022[J]. Pediatrics，2021，148(4)：e2021053745.

[5]袁瑾懿，汪复. WHO报道美国、加拿大流感病毒对奥司他韦的耐药情况[J]. 中国感染与化疗杂志，2009，9(4)：243.

[6]孙平华. 中药抗流感病毒的最新进展[J]. 中医药学刊，2006，21(4)：733-735.

[7]梁宁，晏利姣，张钰菁，等. 中成药临床实践指南制定方法(一)：中成药临床实践指南的发展现状与特点[J]. 中医杂志，2024，65(1)：44-49.

[8]陈雅馨，梁宁，晏利姣，等. 中成药临床实践指南制定方法(二)：指南工作组的建立及利益冲突管理[J]. 中医杂志，2024，65(1)：50-54，59.

[9]胡紫腾，梁宁，晏利姣，等. 中成药临床实践指南制定方法(三)：临床问题的确定[J]. 中医杂志，2024，65(1)：55-59.

[10]张福强，晏利姣，胡紫腾，等. 中成药临床实践指南制定方法(四)：证据检索与评价[J]. 中医杂志，2024，65(1)：60-65.

[11]胡紫腾，梁宁，晏利姣，等. 中成药临床实践指南制定方法(五)：合理用药关键信息的检索和综合[J]. 中医杂志，2024，65(2)：167-171.

[12]张钰菁，梁宁，晏利姣，等. 中成药临床实践指南制定方法(六)：推荐意见形成与呈现[J]. 中医杂志，2024，65(2)：172-178.

[13]张钰菁，张福强，晏利姣，等. 中成药临床实践指南制定方法(七)：指南报告清单及其解读[J]. 中医杂志，2024，65(2)：178-184.

[14]GUYATT G，OXMAN AD，AKL EA，et al. GRADE guidelines：1. Introduction-GRADE evidence profiles and

summary of findings tables[J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(4): 383-394.
[15]马融, 申昆玲. 中成药治疗小儿急性上呼吸道感染临床应用指南(2020年)[J]. 中国中西医结合杂志, 2021, 41(2): 143-150.
[16]周霁云. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗甲型流行性感冒的临床效果分析[J]. 临床研究, 2019, 27(9): 128-129.
[17]刘俊. 小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的效果评价[J]. 中国实用医药, 2019, 14(17): 130-131.
[18]张垚, 罗建峰, 王浩. 小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的疗效及对中医证候改善的效果分析[J]. 海南医学, 2019, 30(24): 3210-3212.
[19]张步有, 贺金娥, 王微, 等. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的临床疗效观察[J]. 宁夏医科大学学报, 2018, 40(12): 1441-1443.
[20]赵彦昌, 吴建军, 张善胜, 等. 奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的疗效观察[J]. 中国医药科学, 2019, 9(2): 38-40.
[21]赵艳春, 李芳芳, 刘丕松. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗甲型流行性感冒的临床观察[J]. 中国民间疗法, 2019, 27(5): 59-60.
[22]程呈. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的疗效探析[J]. 健康必读, 2019, 27(30): 26.
[23]秦晔. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的临床疗效分析[J]. 健康必读, 2019, 27(23): 48.
[24]陆晓萍, 毛顺峰, 林越仙. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗甲型流行性感冒疗效观察[J]. 儿科药学杂志, 2015, 21(2): 24-26.
[25]宋文仕, 张海艳. 小儿豉翘联合奥司他韦治疗儿童流行性感冒临床疗效分析[J]. 临床医药文献电子杂志, 2018, 5(60): 161-162.
[26]苏定邦. 小儿豉翘清热颗粒联合奥司他韦治疗小儿流感[J]. 现代诊断与治疗, 2019, 30(4): 525-527.
[27]张云辉, 季坚卫, 陈娇磊. 小儿豉翘清热颗粒联合磷酸奥司他韦颗粒治疗儿童流行性感冒疗效观察[J]. 医学美学美容, 2018, 27(6): 2-3.
[28]骆冠毅, 刘紫凝, 徐嘉辉, 等. 小儿豉翘清热颗粒联合磷酸奥司他韦治疗小儿乙型流行性感冒[J]. 江西医药, 2019, 54(10): 1250-1253.
[29]高晓慧, 张刚, 罗丽君. 小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒临床疗效观察[J]. 医药前沿, 2019, 9(9): 21-22.
[30]常继霞. 小儿豉翘清热颗粒治疗流行性感冒临床观察[J]. 光明中医, 2019, 34(17): 2647-2649.
[31]马融, 胡思源, 许雅倩, 等. 小儿金翘颗粒治疗儿童轻型流行性感冒风热证多中心随机对照临床研究[J]. 中医杂志, 2020, 61(14): 1242-1246.
[32]HU S, MA R, SHEN K, et al. Efficacy and safety of Qinxiang Qingjie oral solution for the treatment of influenza in children: a randomized, double-blind, multicenter clinical trial[J]. Transl Pediatr, 2022, 11(6): 987-1000.
[33]赵开尖. 小儿柴桂退热颗粒联合磷酸奥司他韦治疗小儿流行性感冒临床研究[J]. 新中医, 2021, 53(22): 117-119.
[34]吕稳莲. 小儿柴桂退热颗粒联合奥司他韦治疗小儿流行性感冒的效果观察[J]. 临床合理用药杂志, 2020, 13(20): 97-98.
[35]俞泽伟, 周优丽, 褚亚苏. 小儿热速清颗粒联合磷酸奥司他韦治疗儿童甲型流感病毒肺炎临床研究[J]. 新中医, 2022, 54(4): 114-117.
[36]冯炽光. 小儿热速清糖浆联合磷酸奥司他韦治疗流行性感冒的疗效分析[J]. 中国卫生标准管理, 2022, 13(9): 138-140.
[37]吴洁. 小儿热速清颗粒联合奥司他韦治疗儿童流感的临床效果[J]. 临床合理用药杂志, 2022, 15(1): 125-127.
[38]尹有会, 芦海燕. 磷酸奥司他韦颗粒联用小儿热速清颗粒治疗儿童流感疗效观察[J]. 中外女性健康研究, 2018, (14): 5, 10.
[39]秦潞平. 小儿热速清颗粒联合磷酸奥司他韦治疗小儿流感的临床效果[J]. 临床合理用药杂志, 2020, 13(28): 105-106.
[40]邢轶维. 小儿热速清颗粒治疗儿童甲型流感的临床效果观察[J]. 内蒙古中医药, 2019, 38(1): 8-9.
[41]方丽. 小儿热速清颗粒治疗儿童甲型流感风热犯卫证临床观察[J]. 新中医, 2018, 50(4): 140-142.
[42]刘晓虹. 小儿热速清口服液联合磷酸奥司他韦治疗流行性感冒的临床疗效[J]. 现代养生, 2018, (18): 96-97.
[43]袁通金. 小儿热速清糖浆治疗对婴幼儿流行性感冒临床疗效、免疫功能及血清炎性因子表达的影响[J]. 中外医疗, 2021, 40(25): 13-15, 27.
[44]陈圣洁, 东蕾, 蒋春颖, 等. 磷酸奥司他韦颗粒剂联合蒲地蓝消炎口服液治疗儿童流感疑似病例的药物经济学评价[J]. 中国药房, 2018, 29(13): 1810-1815.
[45]李娜. 奥司他韦联合蒲地蓝消炎口服液治疗儿童流行性感冒的临床疗效及其药物经济学分析[J]. 临床合理用药杂志, 2021, 14(24): 130-132.
[46]程红珍. 磷酸奥司他韦联合蒲地蓝消炎口服液治疗小儿流感的疗效观察[J]. 北方药学, 2019, 16(6): 79.
[47]花香香. 磷酸奥司他韦颗粒剂联合蒲地蓝消炎口服液

治疗儿童流感疑似病例的药物经济学评价[J]. 中国处方药,2021,19(12):80-81.
[48]黄冬平,黄苑铭,谢丹宇,等. 蒲地蓝消炎口服液治疗婴幼儿流行性感冒临床疗效观察[J]. 天津药学,2018,30(3):31-33.
[49]席永红. 磷酸奥司他韦颗粒联合小儿牛黄清心散治疗小儿流感病毒感染的疗效观察[J]. 当代医学,2018,24(29):67-69.
[50]陈继珍. 小儿牛黄清心散联合磷酸奥司他韦颗粒对流感患儿的临床疗效观察[D]. 武汉:湖北中医药大学,2018.
[51]吴清良. 磷酸奥司他韦颗粒+小儿牛黄清心散用于小儿季节性流感的临床效果及对改善患儿不适症状的作用分析[J]. 北方药学,2021,18(9):72,113.
[52]杨敏,刘敏. 磷酸奥司他韦颗粒联合小儿牛黄清心散治疗小儿季节性流感临床分析[J]. 临床医药文献电子杂志,2018,5(83):49,52.
[53]孙宝霞,徐海波,万广宇,等. 磷酸奥司他韦颗粒联合小儿牛黄清心散治疗小儿季节性流感临床研究[J]. 中国现代药物应用,2014,8(18):4-6.
[54]闫社军. 磷酸奥司他韦颗粒与小儿牛黄清心散治疗小儿季节性流感的疗效探究[J]. 北方药学,2017,14(2):61-62.
[55]马晓琴. 小儿季节性流感100例患者磷酸奥司他韦林颗粒联合小儿牛黄清心散治疗效果观察[J]. 临床医药文献电子杂志,2018,5(68):148,150.
[56]杜颖,吴雅玲,宋伟仓,等. 小儿牛黄清心散联合磷酸奥司他韦颗粒治疗儿童流行性感冒临床研究[J]. 新中医,2020,52(22):101-103.
[57]郭艳. 儿童抗感颗粒治疗小儿流行性感冒46例临床观察[J]. 临床医药文献电子杂志,2019,6(39):171.
[58]鄢军. 抗感颗粒联合奥司他韦对流行性感冒患儿临床症状改善程度的影响[J]. 北方药学,2020,17(4):67-68.
[59]王彦平,王赖儿. 抗感颗粒联合奥司他韦颗粒治疗小儿乙型流感的疗效观察[J]. 内蒙古中医药,2019,38(9):58-59.
[60]陈多姿,程亚艳,魏广友,等. 抗感颗粒联合奥司他韦治疗小儿流行性感冒的临床研究[J]. 现代药物与临床,2019,34(4):1029-1033.
[61]饶观萍,王春辉. 抗感颗粒联合磷酸奥司他韦颗粒对乙型流行性感冒患儿机体炎症的影响[J]. 首都食品与医药,2022,29(23):145-147.
[62]胡思源,李新民,耿福能,等. 抗感颗粒治疗小儿流行性感冒120例多中心随机对照双盲临床研究[J]. 中医杂志,2018,59(6):486-489.
[63]孙霆芳. 小儿双金清热口服液联合奥司他韦治疗甲型流感的效果[J]. 中国卫生标准管理,2019,10(11):71-73.
[64]周金芳,宜雄雄. 小儿双金清热口服液联合奥司他韦治疗甲型流行性感冒的临床研究[J]. 现代药物与临床,2018,33(7):1660-1663.
[65]刘婧. 小儿双金清热口服液佐治甲型流感的临床研究[J]. 包头医学院学报,2017,33(3):62-63.
[66]胡静,于毅,叶宁,等. 热毒宁注射液佐治儿童甲型H1N1流感合并肺炎疗效观察[J]. 中国实用儿科杂志,2011,26(5):388.
[67]吕姗珊,王丽雪. 奥司他韦联合热毒宁注射液治疗儿童重症流感的临床疗效观察[J]. 名医,2019,10(2):241.
[68]叶明阳,涂娟娟,朱小燕. 奥司他韦治疗基础上热毒宁治疗190例儿童甲型H1N1流感疗效观察[J]. 四川医学,2010,31(10):1533-1534.
[69]朱本辉,李玉霞,谢鹤. 喜炎平注射液佐治儿童流行性感冒疗效观察[J]. 中国中西医结合儿科学,2018,10(3):259-261.
[70]谭锦华. 磷酸奥司他韦联合喜炎平治疗儿童甲型流行性感冒效果分析[J]. 承德医学院学报,2018,35(3):215-217.
[71]杜广亮. 喜炎平联合磷酸奥司他韦治疗小儿流行性感冒的疗效观察[J]. 山西医药杂志,2018,47(10):1166-1168.
[72]高智群,林菁. 小儿肺咳颗粒对儿童流行性感冒并发肺炎恢复期临床观察[J]. 深圳中西医结合杂志,2019,29(23):51-52.
[73]郑伟强. 奥司他韦联合小儿肺咳颗粒治疗儿童流行性感冒患者的疗效分析[J]. 海峡药学,2021,33(3):157-159.

(收稿日期:2024-07-10;修回日期:2025-01-16)
[编辑:焦 爽]

附件1　中成药治疗儿童流感临床应用指南（2024年）主要研究过程与方法

1　临床问题的遴选和确定

本指南临床问题的构建采用文献调研和临床调研相结合的方法。前期在文献调研基础上形成了11个临床问题，通过对16位中西医临床专家和方法学专家的咨询和问卷调查，最终形成本指南研究拟解决的6个重要临床问题。1）儿童流感的诊断及临床表现是什么？2）哪些实验室检查指标（如血常规、病原学、影像学）有助于诊断和鉴别儿童流感？3）儿童流感的中医辨证分型有哪些？如何辨证？4）治疗儿童流感的中药有哪些？效果如何？如何使用？5）针对儿童流感的不同病情严重程度，如何选择中医疗法？6）采用中医疗法治疗儿童流感的安全性如何？是否存在禁忌症？其中临床问题1~3可在附件6中获取，临床问题4–6已融合在正文中呈现，例如临床问题6即对应正文13个中成药的“注意事项”。

2　证据的检索与筛选标准

2.1　证据检索策略

计算机检索PubMed、EMBASE、Cochrane Library、中国期刊全文数据库（CNKI）、维普中文科技期刊数据库（VIP）、万方数据库（Wan-Fang）、中国生物医学文献服务系统（SinoMed）已发表文献，检索时间为数据库建库至2022年1月21日。检索策略使用主题词结合自由词检索，中文检索词为“流行性感冒”“流感”“时行感冒”“风温”“风瘟”“温病”“疫病”“儿童”“患儿”“小儿”“儿科”“婴儿”“幼儿”“中药”“草药”“中草药”“中成药”“成药”“中西医”“中医”“复方”“汤剂”“方剂”“随机”“盲法”。英文检索词为“Traditional Chinese medicine”“Chinese herbal medicine”“Chinese material medica”“Chinese proprietary medicine”“Chinese patent medicine”“influenzas”“flu”“children”“child”“RCT”“random”“randomized”。另外手工检索其他相关系统评价及其参考文献。

2.2　证据纳入和排除标准

纳入标准：1）研究类型：随机对照临床试验（randomized controlled trials，RCTs）；2）研究对象：儿童流行性感冒患者；3）干预措施：具有固定工艺生产，质量可控，被中国国家药品监督管理机构批准或备案的中成药；4）对照组：安慰剂、空白对照及其他临床干预方式（例如奥司他韦）；5）结局指标：至少包括总有效率、流感相关症状（发热、咳嗽、鼻塞、流涕、咽喉疼痛、头痛头晕、乏力、肌肉酸痛、惊厥）改善情况、不良反应率其中的一项；6）联合干预需在组间使用一致。

排除标准：1）试验组干预措施联合了其他中医药疗法；2）试验组和对照组采用的基础治疗不一致；3）干预措施不明确或者剂量不固定；4）数据不全导致无法分析或者数据明显异常；5）院内制剂和自制剂。

2.3　中成药的筛选

对于存在RCTs证据的中成药，需同时满足以下条件：所有RCTs研究样本量相加不低于100；中成药为儿童专用药，或者说明书中包含儿童用量的描述（儿童酌减也包含在内）。

对于不存在RCT证据支持的中成药，需同时满足以下条件：专家在后续的德尔菲问卷中推荐该中成药；该中成药为儿童专用药，或者说明书中包含儿童用量的描述（儿童酌减也包含在内）；该中成药在专家中的共识率≥75%。

3　文献筛选及资料提取

2名研究人员独立阅读文献题目及摘要初筛，通过阅读全文复筛，确定纳入文献。根据提前设计的文献信息提取表提取关键信息，并进行交叉核对，当双方出现分歧时，则通过第三方进行讨论解决。资料提取具体内容包括：1）纳入文献的基本信息，包括篇名、作者、发表年份等；2）研究对象的基本信息，包括样本量、性别、年龄、纳入排除标准等；3）干预方法，包括试验组和对照组的干预措施（剂量、服法、疗程）；4）结局指标数据。

4　质量评价

证据评价小组运用系统评价偏倚风险评价工具（a measurement tool to assess systematic reviews，AMSTAR）[1]对纳入的系统评价、Meta分析进行偏倚风险评价。使用Cochrane偏倚风险评价工具（risk of bias，ROB）[2]对随机对照试验研究进行方法学质量评价。评价过程由两人独立完成，若存在分歧，则共同讨论或咨询第三方解决。若有近三年内已发表的高质量系统评价，直接使用其结果；若无，则应用RevMan 5.4软件对结局指标相同、数

据类别一致的中成药的RCTs进行Meta分析。

5 证据等级及推荐强度

使用推荐意见分级的评估、制订及评价（grading of recommendations assessment，development and evaluation，GRADE）方法对证据体和推荐意见进行分级[3]。证据质量分为高（A）、中（B）、低（C）和极低（D）四个级别，分别表示对观察值非常有把握、对观察值有中等把握、对观察值的把握有限和对观察值几乎无把握。当对多个结局指标的证据质量进行分级时，若每个结局指标的分级不完全一致，则最终证据体级别采用“就高不就低”的原则呈现。推荐强度分为强推荐(1)和弱推荐(2)。

6 推荐意见的形成

根据证据概要表制作推荐意见，形成推荐意见决策表，利用德尔菲法，对专家进行2轮问卷调查，针对推荐意见形成共识。推荐强度分为“强推荐”“弱推荐”“不推荐”。“强推荐”表示明确显示干预措施利大于弊，“弱推荐”表示利弊不确定或利弊不相当，“不推荐”表示明确显示干预措施弊大于利。凡是某项治疗措施强推荐人数超过总人数的75%，则为强推荐；推荐人数≥75%，但强推荐人数≤75%，则为弱推荐；推荐人数＜75%，则不推荐。对于已经确定纳入本指南的中成药，参照《中成药临床实践指南报告清单V1.0》[4]邀请专家填写该药的推荐意见表，填写内容包括：用药指征、给药途径、药剂使用细则、用量及频次、停药指征、协同用药、禁忌用药、食疗调护、给药禁忌、不良反应和注意事项等。其中，给药途径、用量及频次、给药禁忌、不良反应和注意事项等内容以说明书为主，而用药指征、药剂使用细则、停药指征、协同用药、禁忌用药和食疗调护等内容以循证证据并结合专家建议为主。

7 指南的发布、推广与更新

本指南拟通过中英双语的形式在期刊论文中发表及推广。本指南根据目前国际指南更新报告规范《更新版指南报告清单》（Checklist for the Reporting of Updated Guidelines，CheckUp）[5]进行更新。更新周期为3~8年，决定是否启动指南更新程序的因素包括：指南发布后是否有新的相应证据出现，证据变化对指南推荐意见的影响，以及指南推荐意见的强度是否发生变化。

参考文献

[1]SHEA BJ, GRIMSHAW JM, WELLS GA, et al. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews[J]. BMC Med Res Methodol, 2007, 7: 10. doi: 10.1186/1471-2288-7-10.

[2]HIGGINS JP, ALTMAN DG, GØTZSCHE PC, et al. The Cochrane Collaboration′s tool for assessing risk of bias in randomised trials[J]. BMJ, 2011, 343: d5928. doi: 10.1136/bmj.d5928.

[3]GUYATT G, OXMAN AD, AKL EA, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables[J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(4): 383-394.

[4]张钰菁，张福强，晏利姣，等. 中成药临床实践指南制定方法（七）：指南报告清单及其解读[J]. 中医杂志，2024，65(2)：178-184.

[5]VERNOOIJ RW, ALONSO-COELLO P, BROUWERS M, et al. Reporting items for updated clinical guidelines: checklist for the reporting of updated guidelines(CheckUp)[J]. PLoS Med, 2017, 14(1): e1002207.

附件2　中成药治疗儿童流感推荐意见概要表

中成药症状	发热	恶寒	咽干、咽痛等咽喉部症状	咳嗽咳痰	喘促	鼻塞流涕	纳呆	腹胀	腹泻	口渴	便干便秘	尿黄	乏力气短	头身疼痛	烦躁	抽搐	动辄汗出
小儿豉翘清热颗粒（1B）	√		○	√		○	√	√			○						
小儿青翘颗粒（1B）	√	√	√														
芩香清解口服液（1B）	√		√	○		○				○	√				○		
小儿柴桂退热颗粒（1C）	√		√			√				○	○	○		√			
小儿热速清颗粒(糖浆、口服液)(2B)	√高热		√	√		○					○			○			
蒲地蓝消炎口服液（2B）	√*		√*														
小儿牛黄清心散（2B）	√高热*				√											√	
抗感颗粒（2C）	√		√			√								√			
开喉剑喷雾剂（儿童型）(2C)			√*														
小儿双金清热口服液（2C）	√低热		√	√													
热毒宁注射液（2C）	√高热	√		√										√			
喜炎平注射液（2C）	√高热*		√*	○*					○*					√*			
小儿肺咳颗粒（2C）				√	○		√○						√				○

注：*表示说明书中未提及，为专家共识所推荐的症状；√表示该中成药治疗的主症，即临床专家选出的3~4个中成药治疗的主要症状；○表示该中成药可治疗的其他症状。1表示强推荐，2表示弱推荐。A、B、C表示证据质量级别，分别为高等级别、中等级别和低等级别。

附件3　中成药治疗儿童流感实施概要表

	发热	恶寒	头身疼痛	动辄汗出	乏力气短	咽喉不适	咳嗽咳痰	鼻塞流涕	喘促	纳呆	腹胀	口渴	腹泻	便干便秘	尿黄	烦躁	抽搐
发热																	
恶寒	②⑪																
头身疼痛	④⑤⑧⑪⑫	⑪															
动辄汗出																	
乏力气短				⑬													
咽喉不适	①②③④⑤⑥⑧⑩⑫	②	④⑤⑧⑫			⑨											
咳嗽咳痰	①③⑤⑩⑪⑫	⑪	⑤⑪⑫	⑬	⑬	①③⑤⑩⑫											
鼻塞流涕	①③④⑤⑧		④⑤⑧			①③④⑤⑧	①③⑤										
喘促	⑦			⑬	⑬		⑬										
纳呆	①			⑬	⑬	①	①⑬	①	⑬								
腹胀	①					①	①	①		①							
口渴	③④		④			③④	③	③④									
腹泻	⑫		⑫			⑫	⑫										
便干便秘	①③④⑤		④⑤			①③④⑤	①③⑤	①③④⑤		①		③④	①				
尿黄	④		④			④		④				④		④			
烦躁	③					③	③	③				③		③			
抽搐	⑦								⑦								

注：①小儿豉翘清热颗粒；②小儿青翘颗粒；③芩香清解口服液；④小儿柴桂退热颗粒；⑤小儿热速清颗粒（糖浆、口服液）；⑥蒲地蓝消炎口服液；⑦小儿牛黄清心散；⑧抗感颗粒；⑨开喉剑喷雾剂（儿童型）；⑩小儿双金清热口服液；⑪热毒宁注射液；⑫喜炎平注射液；⑬小儿肺咳颗粒。

附件4　中成药治疗儿童流感推荐意见总结

在每个中成药推荐使用的临床表现中，下划线症状表示经专家共识后的该中成药治疗的主症，无下划线症状表示该中成药可治疗的其他症状。

推荐意见1 推荐小儿豉翘清热颗粒用于流感患儿，临床表现为发热、咳嗽、鼻塞流涕、咽痛、纳呆、腹胀、便秘者（GRADE证据等级：B；强推荐）。

推荐意见2 推荐小儿青翘颗粒用于流感患儿，临床表现为恶寒发热、咽干、咽痛、咽部灼热者（GRADE证据等级：B；强推荐）。

推荐意见3 推荐芩香清解口服液用于流感患儿，临床表现为发热、咳嗽、鼻塞、流涕、咽红肿痛、便秘、口渴烦躁、舌红苔黄、脉滑数者（GRADE证据等级：B；强推荐）。

推荐意见4 推荐小儿柴桂退热颗粒用于流感患儿，临床表现为发热、头身痛、流涕、咽红、口渴、溲黄、便干者（GRADE证据等级：B；强推荐）。

推荐意见5 推荐小儿热速清颗粒（糖浆、口服液）用于流感患儿，临床表现为高热、咳嗽、鼻塞流涕、咽喉肿痛、头痛、大便干结者（GRADE证据等级：B；弱推荐）。

推荐意见6 推荐蒲地蓝消炎口服液用于流感患儿，临床表现为发热、咽痛者（GRADE证据等级：B；弱推荐）。

推荐意见7 推荐小儿牛黄清心散用于流感患儿，临床表现为高热、咳喘、抽搐者（GRADE证据等级：B；弱推荐）。

推荐意见8 推荐抗感颗粒用于流感患儿，临床表现为发热、鼻塞、喷嚏、咽痛、头痛、全身乏力酸痛者（GRADE证据等级：C；弱推荐）。

推荐意见9 推荐开喉剑喷雾剂（儿童型）用于流感患儿，临床表现为咽部不适、咽喉肿痛者（弱推荐）。

推荐意见10 推荐小儿双金清热口服液用于流感患儿，临床表现为低热、咳嗽、咽红者（GRADE证据等级：C；弱推荐）。

推荐意见11 推荐热毒宁注射液用于流感患儿，临床表现为高热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头身疼痛者（GRADE证据等级：C；弱推荐）。

推荐意见12 推荐喜炎平注射液用于流感患儿，临床表现为高热、咳嗽、咽干咽痛、头身疼痛、腹泻者（GRADE证据等级：C；弱推荐）。

推荐意见13 推荐小儿肺咳颗粒用于流感患儿，临床表现为咳嗽痰多、咳吐不爽、气短、乏力、喘促、汗多、纳差、舌红苔厚者（GRADE证据等级：C；弱推荐）。

附件5　中成药治疗儿童流感临床应用的其他参考信息

1　小儿豉翘清热颗粒

证据概述：共纳入15项[1-15]小儿豉翘清热颗粒联合奥司他韦与奥司他韦单用对比治疗流感患儿的RCTs，Meta分析结果显示，试验组在提高临床总有效率（15项RCTs，1888例）[*RR*=1.15，95%*CI*（1.12，1.19），I^2=0%，GRADE证据等级：B]、减少退热时间（12项RCTs，1546例）[*MD*=−16.33，95%*CI*（−21.13，−11.54），I^2=95%，GRADE证据等级：B]、止咳时间（8项RCTs，1054例）[*MD*=−20.27，95%*CI*（−27.03，−13.51），I^2=89%，GRADE证据等级：B]、鼻塞流涕时间（6项RCTs，636例）[*MD*=−15.29，95%*CI*（−23.90，−6.67），I^2=95%，GRADE证据等级：B]、咽痛时间（3项RCTs，452例）[*MD*=−9.92，95%*CI*（−12.13，−7.72），I^2=0%，GRADE证据等级：B]方面均优于对照组。6项RCTs（902例）描述了不良反应，结果显示，小儿豉翘清热颗粒联合奥司他韦对比奥司他韦单用，能有效减少流感患儿治疗过程中不良反应发生率[*RR*=0.50，95%*CI*(0.31,0.79)，I^2=0%]。

推荐理由：该药属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录2023》[16]中乙类药品；在专家共识会议中推荐比例为100%（强推荐比例为95%），并在《儿童流行性感冒中西医结合诊疗指南2023》[17]、《儿童流行性感冒中西医结合防治专家共识》[18]和《流行性感冒诊疗方案2020》[19]等指南或共识中均被推荐用于流感患儿的治疗，已发表的RCTs也表明其在治疗发热、咳嗽、鼻塞流涕、咽痛等症状具有较好的疗效，专家根据其组成及临床经验，认为该药在纳呆、腹胀、便秘中也具有一定的效果。

药理作用：药效学试验结果显示，本品对小鼠巴豆油所致耳廓肿胀和大鼠角叉菜胶足跖肿胀有抑制作用，对酵母引起的大鼠发热和消毒牛奶所引起的家兔非感染性发热，也均有降温作用。并能增加便秘小鼠的排便量，降低醋酸引起的小鼠扭体次数，提高小鼠水浴甩尾的痛阈值。（说明书）

尚未获取的信息：停用方法、监测指标和药物经济学。

2　小儿青翘颗粒

证据概述：共纳入1项（240例）[20]小儿青翘颗粒单用治疗儿童流感的分层区组随机、阳性药平行对照、非劣效检验、多中心临床试验。结果显示，小儿金翘颗粒与磷酸奥司他韦颗粒相比，两组的临床痊愈时间均为3天（P>0.05）；完全退热时间分别为42、36小时，组间比较，全分析集（FAS）分析差异有统计学意义（P<0.05），符合方案集（PPS）分析差异无统计学意义（P>0.05）；两组在并发症、重症及危重症发生率组间比较差异均无统计学意义（P>0.05）。小儿青翘颗粒疗效非劣于磷酸奥司他韦颗粒。治疗组与对照组分别发现23、18例不良事件，不良反应9、10例；两组不良事件与不良反应发生率比较，差异均无统计学意义（P>0.05）。

推荐理由：该药属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录2023》[16]中乙类药品，并被纳入《国家基本药物目录2018》[21]；在专家共识会议中推荐比例为100%（强推荐比例为85.7%），已发表的RCTs表明其具有较好的退热疗效，专家根据其组成及临床经验，认为该药在恶寒、咽干、咽痛、咽部灼热中也具有一定的效果。

药理作用：实验药理学试验结果显示，本品具有抗炎、镇痛、解热作用。提高感染乙型溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌小鼠的存活率；减轻角叉菜胶致大鼠的急性炎症反应；降低角叉菜胶致热大鼠和三联菌苗致热家兔的发热程度；减轻热板和醋酸所致的小鼠疼痛。（说明书）

尚未获取的信息：食疗调护、停用方法、监测指标和药物经济学。

3　芩香清解口服液

证据概述：共纳入1项（231例）[22]芩香清解口服液单用治疗儿童流感的随机、双盲、双模拟、阳性对照、多中心临床试验，结果显示，芩香清解口服液与磷酸奥司他韦颗粒相比，两组的临床痊愈时间均为3天（P>0.05），完全退热时间均为36小时（P>0.05）；两组在并发症、重症及危重症发生率组间比较差异均无统计学意义（P>0.05）。芩香清解口服液治疗儿童流感的疗效与奥司他韦相当。芩香清解口服液组中的14名患者（12.39%）和奥司他韦组中的14名患者（12.50%）分别发生了至少一种不良事件；芩香清解口服液组发生了1起严重不良事件；两组间不良事件或药物不良反应的发生率差异无统计学意义（P>0.05）。

推荐理由：该药属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录2023》[16]中乙类药品，并在《儿童流行性感冒中西医结合诊疗指南2023》[17]、《儿童流行性感冒中西医结合防治专家共识》[18]等指南（共识）中均被推荐用于流感患儿的治疗；在专家共识会议中推荐比例为100%（强推荐比例为85.0%），已发表的RCTs表明其具有较好的退热疗效，专家根据其组成及临床经验，认为该药对于缓解咽红肿痛、便秘、鼻塞、流涕、咳嗽、口渴烦躁也具有一定的效果。

药理作用：非临床药效学试验结果显示，本品能升高金黄色葡萄球菌感染小鼠的存活率；能延长枸橼酸引咳豚鼠的咳嗽潜伏期并减少咳嗽次数；能增加小鼠气管分泌酚红含量；能抑制耳静脉注射三联疫苗所致家兔体温升高和皮下注射2,4-二硝基酚所致大鼠体温升高；对热板法和扭体法所致小鼠疼痛有一定的镇痛作用；对二甲苯致小鼠耳肿胀和角叉菜胶所致大鼠足跖肿胀有一定的抑制作用。（说明书）

尚未获取的信息：食疗调护、停用方法、监测指标和药物经济学。

4　小儿柴桂退热颗粒

证据概述：共纳入2项（164例）[23-24]小儿柴桂退热颗粒联合奥司他韦与奥司他韦单用对比治疗儿童流感的RCTs，Meta分析结果显示，试验组在提高临床总有效率（2项RCTs，164例）[*RR*=1.21，95%*CI*（1.08，1.37），I^2=0%，GRADE证据等级：C]、减少鼻塞流涕时间（1项RCT，100例）[*MD*=-0.76，95%*CI*（-0.85，-0.67），GRADE证据等级：C]、咽痛时间（1项RCT，100例）[*MD*=-0.32，95%*CI*（-0.38，-0.26），GRADE证据等级：C]方面均优于对照组。纳入1项RCT（100例）报告了小儿柴桂退热颗粒联合奥司他韦可见恶心、呕吐等不良反应，与单用奥司他韦相比，差异无统计学意义[*RR*=0.14，95%*CI*（0.02，1.12）]。

推荐理由：该药属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录2023》[16]中乙类药品，同时被纳入《国家基本药物目录2018》[21]；在专家共识会议中推荐比例为100%（强推荐比例为80.0%），已发表的RCTs表明其治疗鼻塞流涕、咽痛等症状具有较好的疗效，专家根据其组成及临床经验，认为该药对于缓解发热、头身痛、口渴、溲黄便干也具有一定的效果。

尚未获取的信息：停用方法、监测指标、药物经济学和药理作用。

5　小儿热速清颗粒（糖浆、口服液）

证据概述：共纳入9项（1409例）[25-33]小儿热速清颗粒/糖浆/口服液联合奥司他韦与奥司他韦单用对比治疗流感患儿的RCTs，Meta分析结果显示，试验组在提高临床总有效率（7项RCTs，849例）[*RR*=1.17，95%*CI*（1.03，1.32），I^2=89%，GRADE证据等级：B]、减少退热时间（8项RCTs，1331例）[*MD*=-0.49，95%*CI*（-0.67，-0.31），I^2=92%，GRADE证据等级：C]、止咳时间（4项RCTs，480例）[*MD*=-0.98，95%*CI*（-1.64，-0.32），I^2=95%，GRADE证据等级：C]、咽痛时间（3项RCTs，422例）[*MD*=-1.30，95%*CI*（-2.37，-0.22），I^2=99%，GRADE证据等级：C]、头痛时间（1项RCT，94例）[*MD*=-0.85，95%*CI*（-1.02，-0.68），GRADE证据等级：C]、流涕时间（1项RCT，94例）[*MD*=-1.08，95%*CI*（-1.43，-0.73），GRADE证据等级：C]方面均优于对照组。3项RCTs（332例）描述了不良反应，结果显示，小儿热速清颗粒/糖浆联合奥司他韦对比奥司他韦单用，能有效降低流感患儿治疗的不良事件发生率[*RR*=0.28，95%*CI*（0.12，0.66），I^2=0%]。

推荐理由：该药属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录2023》[16]中乙类药品，颗粒剂和口服液同时被纳入《国家基本药物目录2018》[21]，并在《儿童流行性感冒中西医结合诊疗指南2023》[17]等指南中被推荐用于流感患儿的治疗；在专家共识会议中推荐比例为100%（强推荐比例为68.4%），已发表的RCTs表明其在治疗发热、咽痛、咳嗽、头痛、流涕等症状具有较好的疗效，专家根据其组成及临床经验，认为该药对于缓解大便干结也具有一定的效果。

尚未获取的信息：食疗调护、停用方法、监测指标、药物经济学和药理作用。

6　蒲地蓝消炎口服液

证据概述：共纳入5项（633例）[34-38]蒲地蓝消炎口服液联合奥司他韦（或基础对症疗法）治疗儿童流感的RCTs，其中4项为奥司他韦的对照研究，1项为基础对症治疗的对照研究。本指南对这5项研究的Meta分析结果显示，试验组在提高临床总有效率（5项RCTs，633例）[*RR*=1.18，95%*CI*

（1. 11，1. 25），I^2=0%，GRADE证据等级：B］、减少发热时间（3项RCTs，383例）［*MD*=−0. 72，95%*CI*（−0. 92，−0. 53），I^2=84%，GRADE证据等级：C］、咳嗽时间（2项RCTs，278例）［*MD*=−2. 23，95%*CI*（−3. 72，−0. 74），I^2=99%，GRADE证据等级：C］方面均优于对照组。纳入2项RCTs（250例）报告了蒲地蓝消炎口服液联合奥司他韦可见腹泻、恶心、呕吐等不良反应，与单用西药相比，差异无统计学意义［*RR*=0. 34，95%*CI*（0. 11，1. 04）］。

推荐理由：该药在专家共识会议中推荐比例为100%（强推荐比例为65. 0%），已发表的RCTs表明其治疗发热、咳嗽等症状具体较好的疗效。

药理作用：本品对大肠杆菌和脆弱类杆菌所致小鼠皮下混合感染的脓肿形成有一定抑制作用，对金黄色葡萄球菌和脆弱类杆菌腹腔注射所致小鼠感染有一定的保护作用，对二甲苯致小鼠耳廓肿胀和角叉菜胶所致大鼠足跖肿胀均有一定的抑制作用，对伤寒菌苗所致家兔体温升高也有一定的抑制作用。（说明书）

尚未获取的信息：不同年龄段具体用量及频次、停用方法、监测指标和药物经济学。

7　小儿牛黄清心散

证据概述：共纳入8项（1256例）[39-46]小儿牛黄清心散联合奥司他韦与奥司他韦单用对比治疗儿童流感的RCTs，Meta分析结果显示，试验组在提高临床总有效率（8项RCTs，1256例）［*RR*=1. 16，95%*CI*（1. 08，1. 24），I^2=68%，GRADE证据等级：B］、减少退热时间（6项RCTs，976例）［*MD*=−0. 57，95%*CI*（−0. 83，−0. 31），I^2=87%，GRADE证据等级：C］、止咳时间（6项RCTs，976例）［*MD*=−0. 68，95%*CI*（−1. 03，−0. 33），I^2=85%，GRADE证据等级：B］、鼻塞流涕时间（2项RCTs，224例）［*MD*=−0. 48，95%*CI*（−0. 90，−0. 05），I^2=86%，GRADE证据等级：D］、咽痛时间（5项RCTs，834例）［*MD*=−0. 58，95%*CI*（−0. 90，−0. 27），I^2=89%，GRADE证据等级：C］、高热惊厥发生例数［*RR*=0. 14，95%*CI*（0. 02，1. 15），I^2=0%，GRADE证据等级：C］（2项RCTs，176例）方面均优于对照组。2项RCTs（216例）描述了不良反应，小儿牛黄清心散联合奥司他韦对比奥司他韦单用，能有效减少流感患儿治疗过程中不良反应发生率［*RR*=0. 39，95%*CI*（0. 16，0. 96），I^2=0%］。

推荐理由：该药在专家共识会议中推荐比例为78. 9%（强推荐比例为26. 3%），已发表的RCTs表明其治疗发热、咳嗽、惊厥、鼻塞流涕、咽痛等症状具体较好的疗效。

尚未获取的信息：停用方法、不良反应、慎用症、监测指标、药物经济学和药理作用。

8　抗感颗粒

证据概述：共纳入6项（663例）[47-52]抗感颗粒治疗儿童流感的RCTs，1项为抗感颗粒单用的多中心、随机区组、双盲双模拟、平行对照研究，5项为抗感颗粒联合奥司他韦的RCTs。对这6项研究的Meta分析结果显示，与利巴韦林颗粒相比，抗感颗粒治疗儿童流感能缩短完全退热时间、临床痊愈时间；提高中医证候疗效，缓解发热、咽痛，优于利巴韦林颗粒（*P*＜0. 01），同时具有良好的安全性。与奥司他韦单用相比，在此基础上联用抗感颗粒可以提高临床总有效率（5项RCTs，423例）［*RR*=1. 22，95%*CI*（1. 13，1，32），I^2=0%，GRADE证据等级：C］，减少发热时间（2项RCTs，152例）［*MD*=−0. 45，95%*CI*（−0. 59，−0. 30），I^2=0%，GRADE证据等级：C］、鼻塞时间（1项RCT，90例）［*MD*=−2. 24，95%*CI*（−3. 04，−1. 44）］和咽痛时间（1项RCT，90例）［*MD*=−2. 24，95%*CI*（−3. 09，−1. 39）］，效果优于对照组。

推荐理由：该药在专家共识会议中推荐比例为81%，并在《儿童流行性感冒中西医结合防治专家共识》[18]等指南中被推荐用于流感患儿的治疗；已发表的RCTs表明其具有较好缓解发热、鼻塞、咽痛的疗效，并能提高治疗的总有效率，专家根据其组成及临床经验，认为该药在头痛、喷嚏、全身乏力酸痛中也具有一定的效果。

尚未获取的信息：停用方法、监测指标、药物经济学和药理作用。

9　开喉剑喷雾剂（儿童型）

推荐理由：该药在专家共识会议中推荐比例为81%，并在《儿童流行性感冒中西医结合防治专家共识》[18]等指南中被推荐用于流感患儿的治疗。

尚未获取的信息：临床应用证据描述、具体用量及频次、食疗调护、饮食禁忌、停用方法、监测指标、药物经济学和药理作用。

10　小儿双金清热口服液

证据概述：共纳入3项（387例）[53-55]小儿双金清热口服液联合西药治疗儿童流感的RCTs，2项

为奥司他韦的对照研究，1项为常规的对照研究。本指南对这3项研究的Meta分析结果显示，试验组在提高临床总有效率（3项RCTs，387例）［*RR*=1.17，95%*CI*（1.09，1.26），I^2=0%，GRADE证据等级：C］、减少发热时间（2项RCTs，273例）［*MD*=−0.13，95%*CI*（−0.19，−0.07），I^2=0%，GRADE证据等级：D］方面均优于对照组。2项RCTs（273例）描述了不良反应，结果显示，小儿双金清热口服液联合奥司他韦对比奥司他韦单用，能有效降低流感患儿治疗的不良事件发生率［*RR*=0.26，95%*CI*（0.11，0.62），I^2=0%］。

推荐理由：该药在专家共识会议中推荐比例为100%（强推荐比例为52.6%），已发表的RCTs表明其具有较好的退热疗效，并能提高治疗的总有效率，专家根据其组成及临床经验，认为该药在咳嗽、咽红中也具有一定的效果。

尚未获取的信息：不同年龄段具体用量及频次、食疗调护、停用方法、监测指标、药物经济学和药理作用。

11　热毒宁注射液

证据概述：共纳入3项（326例）[56-58]热毒宁注射液联合奥司他韦治疗儿童流感的RCTs，Meta分析显示，试验组在提高临床总有效率(3项RCTs，326例）［*RR*=1.11，95%*CI*（1.04，1.18），I^2=0%，GRADE证据等级：C］、减少退热时间（1项RCT，78例）［*MD*=−0.50，95%*CI*（−0.94，−0.06），GRADE证据等级：C］、止咳时间(1项RCT,78例）［*MD*=−0.46，95%*CI*（−0.85，−0.07），GRADE证据等级：C］方面均优于对照组。

推荐理由：该药属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录2023》[16]中乙类药品，并在《儿童流行性感冒中西医结合诊疗指南2023》[17]、《儿童流行性感冒中西医结合防治专家共识》[18]等指南（共识）中均被推荐用于流感患儿的治疗；在专家共识会议中推荐比例为85.0%（强推荐比例为50.0%），已发表的RCTs表明其具有较好的退热止咳疗效，专家根据其组成及临床经验，认为该药对于缓解头身疼痛、微恶风寒、痰黄等也具有一定的效果。

尚未获取的信息：食疗调护、饮食禁忌、停用方法、药品贮藏、药物经济学和药理作用。

12　喜炎平注射液

证据概述：共纳入3项（196例）[59-61]喜炎平注射液联合奥司他韦（或基础对症治疗）治疗儿童流感的RCTs，其中2项为奥司他韦的对照研究，1项为奥司他韦和基础对症治疗的对照研究。本指南对这3项研究的Meta分析结果显示，试验组在提高临床总有效率（3项RCTs，196例）［*RR*=1.22，95%*CI*（1.08，1.37），I^2=0%，GRADE证据等级：C］、减少发热时间（3项RCTs，196例）［*MD*=−0.98，95%*CI*（−1.40，−0.56），I^2=92%，GRADE证据等级：C］、咳嗽时间(2项RCTs,160例）［*MD*=−0.77，95%*CI*（−0.90，−0.64），I^2=0%，GRADE证据等级：C］方面均优于对照组。纳入2项RCTs（100例）报告了喜炎平注射液联合奥司他韦（或基础对症治疗）可见腹泻、呕吐、头晕、荨麻疹伴瘙痒等不良反应，与单用西药相比，差异无统计学意义［*RR*=1.74，95%*CI*（0.40，7.61）］。1项研究对不良反应中的荨麻疹予停止使用喜炎平注射液，并予抗过敏治疗，停药1天后荨麻疹完全消退，无后遗症出现。

推荐理由：该药属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录2023》[16]中乙类药品，并在《儿童流行性感冒中西医结合诊疗指南2023》[17]、《儿童流行性感冒中西医结合防治专家共识》[18]等指南（共识）中均被推荐用于流感患儿的治疗；在专家共识会议中推荐比例为85.0%（强推荐比例为70.0%），已发表的RCTs表明其具有较好的退热止咳疗效，专家根据其组成及临床经验，认为该药对于缓解头身疼痛、咽干咽痛、腹泻等也具有一定的效果。

尚未获取的信息：食疗调护、饮食禁忌、停用方法、药品贮藏、监测指标、药物经济学和药理作用。

13　小儿肺咳颗粒

证据概述：共纳入2项（164例）[62-63]小儿肺咳颗粒联合西药治疗儿童流感的RCTs，1项为奥司他韦和头孢噻肟钠舒巴坦钠的对照研究，1项为奥司他韦的对照研究。本指南对这2项研究的Meta分析结果显示，试验组在提高临床总有效率（2项RCTs，142例）［*RR*=1.20，95%*CI*（1.04，1.39），I^2=0%，GRADE证据等级：C］、减少发热时间（2项RCTs，142例）［*MD*=−1.51，95%*CI*（−2.58，−0.43），I^2=89%，GRADE证据等级：C］、咳嗽时间（1项RCT，62例）［*MD*=−2.04，95%*CI*（−2.68，−1.40），GRADE证据等级：D］、鼻塞时间（1项RCT，62例）［*MD*=−2.03，95%*CI*（−2.61，−1.45），

GRADE证据等级：D］方面均优于对照组。纳入1项RCT（80例）报告了小儿肺咳颗粒联合奥司他韦和头孢噻肟钠舒巴坦钠可见恶心、腹泻等不良反应，与单用西药相比，差异无统计学意义［*RR*=1.50，95%*CI*（0.26，8.50）］。

推荐理由：该药属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录2023》[16]中乙类药品，并被纳入《国家基本药物目录2018》[21]；在专家共识会议中推荐比例为75.0%（强推荐比例为35.0%），已发表的RCTs表明其具有较好的止咳作用，专家根据其组成及临床经验，认为该药对于缓解气短、乏力、喘促、汗多、纳差等也具有一定的效果。

尚未获取的信息：协同用药、停用方法、监测指标、药物经济学和药理作用。

参考文献

[1]周霁云. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗甲型流行性感冒的临床效果分析[J]. 临床研究,2019,27(9):128-129.

[2]刘俊. 小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的效果评价[J]. 中国实用医药,2019,14(17):130-131.

[3]张垚,罗建峰,王浩. 小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的疗效及对中医证候改善的效果分析[J]. 海南医学,2019,30(24):3210-3212.

[4]张步有,贺金娥,王微,等. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的临床疗效观察[J]. 宁夏医科大学学报,2018,40(12):1441-1443.

[5]赵彦昌,吴建军,张善胜,等. 奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的疗效观察[J]. 中国医药科学,2019,9(2):38-40.

[6]赵艳春,李芳芳,刘丕松. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗甲型流行性感冒的临床观察[J]. 中国民间疗法,2019,27(5):59-60.

[7]程呈. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的疗效探析[J]. 健康必读,2019,27(30):26.

[8]秦晔. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒的临床疗效分析[J]. 健康必读,2019,27(23):48.

[9]陆晓萍,毛顺峰,林越仙. 磷酸奥司他韦联合小儿豉翘清热颗粒治疗甲型流行性感冒疗效观察[J]. 儿科药学杂志,2015,21(2):24-26.

[10]宋文仕,张海艳. 小儿豉翘联合奥司他韦治疗儿童流行性感冒临床疗效分析[J]. 临床医药文献电子杂志,2018,5(60):161-162.

[11]苏定邦. 小儿豉翘清热颗粒联合奥司他韦治疗小儿流感[J]. 现代诊断与治疗,2019,30(4):525-527.

[12]张云辉,季坚卫,陈娇磊. 小儿豉翘清热颗粒联合磷酸奥司他韦颗粒治疗儿童流行性感冒疗效观察[J]. 医学美学美容,2018,27(6):2-3.

[13]骆冠毅,刘紫凝,徐嘉辉,等. 小儿豉翘清热颗粒联合磷酸奥司他韦治疗小儿乙型流行性感冒[J]. 江西医药,2019,54(10):1250-1253.

[14]高晓慧,张刚,罗丽君. 小儿豉翘清热颗粒治疗儿童流行性感冒临床疗效观察[J]. 医药前沿,2019,9(9):21-22.

[15]常继霞. 小儿豉翘清热颗粒治疗流行性感冒临床观察[J]. 光明中医,2019,34(17):2647-2649.

[16]中华人民共和国人力资源和社会保障部. 国家医保局 人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》的通知[EB/OL]. (2024-01-17)[2024-11-04]. https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/shbx_4216/gsbx/202401/t20240117_512335.html.

[17]王雪峰,王力宁,邓力,等. 儿童流行性感冒中西医结合诊疗指南[J]. 中国中西医结合儿科学,2024,16(2):93-101.

[18]王雪峰,尚云晓. 儿童流行性感冒中西医结合防治专家共识[J]. 中国中西医结合儿科学,2021,13(5):369-374.

[19]国家卫生健康委办公厅,国家中医药管理局办公室. 流行性感冒诊疗方案(2020年版)[J]. 中国病毒病杂志,2021,11(1):1-5.

[20]马融,胡思源,许雅倩,等. 小儿金翘颗粒治疗儿童轻型流行性感冒风热证多中心随机对照临床研究[J]. 中医杂志,2020,61(14):1242-1246.

[21]国家卫生健康委员会,国家中医药管理局. 关于印发国家基本药物目录(2018年版)的通知[EB/OL]. (2018-12-31)[2024-11-05]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5435470.htm.

[22]HU S,MA R,SHEN K,et al. Efficacy and safety of Qinxiang Qingjie oral solution for the treatment of influenza in children:a randomized,double-blind,multicenter clinical trial[J]. Transl Pediatr,2022,11(6):987-1000.

[23]赵开尖. 小儿柴桂退热颗粒联合磷酸奥司他韦治疗小儿流行性感冒临床研究[J]. 新中医,2021,53(22):117-119.

[24]吕稳莲. 小儿柴桂退热颗粒联合奥司他韦治疗小儿流行性感冒的效果观察[J]. 临床合理用药杂志,2020,13(20):97-98.

[25]俞泽伟,周优丽,褚亚苏. 小儿热速清颗粒联合磷酸奥司他韦治疗儿童甲型流感病毒肺炎临床研究[J]. 新中医,2022,54(4):114-117.

[26]冯炽光. 小儿热速清糖浆联合磷酸奥司他韦治疗流行性感冒的疗效分析[J]. 中国卫生标准管理,2022,13(9):138-140.

[27]吴洁. 小儿热速清颗粒联合奥司他韦治疗儿童流感的临床效果[J]. 临床合理用药杂志,2022,15(1):125-127.

[28]尹有会,芦海燕. 磷酸奥司他韦颗粒联用小儿热速清颗粒治疗儿童流感疗效观察[J]. 中外女性健康研究,2018,(14):5,10.
[29]秦潞平. 小儿热速清颗粒联合磷酸奥司他韦治疗小儿流感的临床效果[J]. 临床合理用药杂志,2020,13(28):105-106.
[30]邢轶维. 小儿热速清颗粒治疗儿童甲型流感的临床效果观察[J]. 内蒙古中医药,2019,38(1):8-9.
[31]方丽. 小儿热速清颗粒治疗儿童甲型流感风热犯卫证临床观察[J]. 新中医,2018,50(4):140-142.
[32]刘晓虹. 小儿热速清口服液联合磷酸奥司他韦治疗流行性感冒的临床疗效[J]. 现代养生,2018(18):96-97.
[33]袁通金. 小儿热速清糖浆治疗对婴幼儿流行性感冒临床疗效、免疫功能及血清炎性因子表达的影响[J]. 中外医疗,2021,40(25):13-15,27.
[34]陈圣洁,东蕾,蒋春颖,等. 磷酸奥司他韦颗粒剂联合蒲地蓝消炎口服液治疗儿童流感疑似病例的药物经济学评价[J]. 中国药房,2018,29(13):1810-1815.
[35]李娜. 奥司他韦联合蒲地蓝消炎口服液治疗儿童流行性感冒的临床疗效及其药物经济学分析[J]. 临床合理用药杂志,2021,14(24):130-132.
[36]程红珍. 磷酸奥司他韦联合蒲地蓝消炎口服液治疗小儿流感的疗效观察[J]. 北方药学,2019,16(6):79.
[37]花香香. 磷酸奥司他韦颗粒剂联合蒲地蓝消炎口服液治疗儿童流感疑似病例的药物经济学评价[J]. 中国处方药,2021,19(12):80-81.
[38]黄冬平,黄苑铭,谢丹宇,等. 蒲地蓝消炎口服液治疗婴幼儿流行性感冒临床疗效观察[J]. 天津药学,2018,30(3):31-33.
[39]席永红. 磷酸奥司他韦颗粒联合小儿牛黄清心散治疗小儿流感病毒感染的疗效观察[J]. 当代医学,2018,24(29):67-69.
[40]陈继珍. 小儿牛黄清心散联合磷酸奥司他韦颗粒对流感患儿的临床疗效观察[D]. 武汉:湖北中医药大学,2018.
[41]吴清良. 磷酸奥司他韦颗粒+小儿牛黄清心散用于小儿季节性流感的临床效果及对改善患儿不适症状的作用分析[J]. 北方药学,2021,18(9):72,113.
[42]杨敏,刘敏. 磷酸奥司他韦颗粒联合小儿牛黄清心散治疗小儿季节性流感临床分析[J]. 临床医药文献电子杂志,2018,5(83):49,52.
[43]孙宝霞,徐海波,万广宇,等. 磷酸奥司他韦颗粒联合小儿牛黄清心散治疗小儿季节性流感临床研究[J]. 中国现代药物应用,2014,8(18):4-6.
[44]闫社军. 磷酸奥司他韦颗粒与小儿牛黄清心散治疗小儿季节性流感的疗效探究[J]. 北方药学,2017,14(2):61-62.
[45]马晓琴. 小儿季节性流感100例患者磷酸奥司他韦林颗粒联合小儿牛黄清心散治疗效果观察[J]. 临床医药文献电子杂志,2018,5(68):148,150.
[46]杜颖,吴雅玲,宋伟仓,等. 小儿牛黄清心散联合磷酸奥司他韦颗粒治疗儿童流行性感冒临床研究[J]. 新中医,2020,52(22):101-103.
[47]郭艳. 儿童抗感颗粒治疗小儿流行性感冒46例临床观察[J]. 临床医药文献电子杂志,2019,6(39):171.
[48]鄢军. 抗感颗粒联合奥司他韦对流行性感冒患儿临床症状改善程度的影响[J]. 北方药学,2020,17(4):67-68.
[49]王彦平,王赖儿. 抗感颗粒联合奥司他韦颗粒治疗小儿乙型流感的疗效观察[J]. 内蒙古中医药,2019,38(9):58-59.
[50]陈多姿,程亚艳,魏广友,等. 抗感颗粒联合奥司他韦治疗小儿流行性感冒的临床研究[J]. 现代药物与临床,2019,34(4):1029-1033.
[51]饶观萍,王春辉. 抗感颗粒联合磷酸奥司他韦颗粒对乙型流行性感冒患儿机体炎症的影响[J]. 首都食品与医药,2022,29(23):145-147.
[52]胡思源,李新民,耿福能,等. 抗感颗粒治疗小儿流行性感冒120例多中心随机对照双盲临床研究[J]. 中医杂志,2018,59(6):486-489.
[53]孙霆芳. 小儿双金清热口服液联合奥司他韦治疗甲型流感的效果[J]. 中国卫生标准管理,2019,10(11):71-73.
[54]周金芳,宜雄雄. 小儿双金清热口服液联合奥司他韦治疗甲型流行性感冒的临床研究[J]. 现代药物与临床,2018,33(7):1660-1663.
[55]刘婧. 小儿双金清热口服液佐治甲型流感的临床研究[J]. 包头医学院学报,2017,33(3):62-63.
[56]胡静,于毅,叶宁,等. 热毒宁注射液佐治儿童甲型H1N1流感合并肺炎疗效观察[J]. 中国实用儿科杂志,2011,26(5):388.
[57]吕姗珊,王丽雪. 奥司他韦联合热毒宁注射液治疗儿童重症流感的临床疗效观察[J]. 名医,2019,10(2):241.
[58]叶明阳,涂娟娟,朱小燕. 奥司他韦治疗基础上热毒宁治疗190例儿童甲型H1N1流感疗效观察[J]. 四川医学,2010,31(10):1533-1534.
[59]朱本辉,李玉霞,谢鹤. 喜炎平注射液佐治儿童流行性感冒疗效观察[J]. 中国中西医结合儿科学,2018,10(3):259-261.
[60]谭锦华. 磷酸奥司他韦联合喜炎平治疗儿童甲型流行性感冒效果分析[J]. 承德医学院学报,2018,35(3):215-217.
[61]杜广亮. 喜炎平联合磷酸奥司他韦治疗小儿流行性感冒的疗效观察[J]. 山西医药杂志,2018,47(10):1166-1168.
[62]高智群,林菁. 小儿肺咳颗粒对儿童流行性感冒并发肺炎恢复期临床观察[J]. 深圳中西医结合杂志,2019,29(23):51-52.
[63]郑伟强. 奥司他韦联合小儿肺咳颗粒治疗儿童流行性感冒患者的疗效分析[J]. 海峡药学,2021,33(3):157-159.

附件6　儿童流感的诊断及辨证分型

临床问题1：儿童流感的临床表现及诊断是什么？临床问题2：哪些实验室检查指标（如血常规、病原学、影像学）有助于诊断和鉴别儿童流感？临床问题3：儿童流感的中医辨证分型有哪些？如何辨证？

1　诊断

本指南中有关儿童流感的临床表现、实验室检查、诊断标准和鉴别诊断主要参考由国家卫生健康委员会和国家中医药管理局发布的《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》[1]、由国家呼吸系统疾病临床医学研究中心和中华医学会儿科学分会呼吸学组牵头制定的《儿童流感诊断与治疗专家共识（2020年版）》[2]、由中国中西医结合学会儿科专业委员会呼吸学组和中华中医药学会儿童健康协同创新平台专家组牵头制定的《儿童流行性感冒中西医结合防治专家共识》[3]。

1.1　临床表现[1-2]

主要以发热、头痛、肌痛和全身不适为首发症状，体温可达39~40 ℃，可有畏寒、寒战，多伴全身肌肉关节酸痛、乏力、食欲不振等全身症状，常有咽喉红肿疼痛、干咳，可有鼻塞、流涕、胸骨后不适，颜面潮红，眼结膜充血等。部分患者症状轻微或无症状。儿童的发热程度通常高于成人，患乙型流感时恶心、呕吐、腹泻等消化道症状也较成人多见。新生儿可仅表现为嗜睡、拒奶、呼吸暂停等。无并发症的患儿病程呈自限性，多于发病3~7天后发热逐渐消退，全身症状好转，但咳嗽、体力恢复常需1~2周。肺炎是流感患儿最常见的并发症。

1.2　西医诊断[2-3]

1.2.1　*流感样病例*　在流感流行季节，出现：1）发热，体温≥38 ℃；2）伴有咳嗽和/或咽痛。

1.2.2　*临床诊断病例*　出现上述流感临床表现，有流行病学史（发病前7天内在无有效个人防护的情况下与疑似或确诊流感患者有密切接触，或属于流感样病例聚集发病者之一，或有明确传染他人的证据）且排除其他引起流感样症状的疾病。

1.2.3　*确诊流感病例*　符合上述疑似流感病例诊断标准，有下列1项或1项以上实验室检测阳性者，可以确诊流感：1）流感病毒核酸检测阳性（可采用Realtime-PCR或RT-PCR方法）；2）流感病毒快速抗原检测阳性，结合流行病学史判断；3）流感病毒分离培养阳性；4）恢复期较急性期血清抗流感病毒特异性IgG抗体水平呈4倍或4倍以上升高。

1.2.4　*重症流感判断标准*　流感病例出现下列1项或1项以上情况者为重症流感病例：1）呼吸困难和/或呼吸频率增快：5岁以上儿童＞30次/min；1~5岁＞40次/min；2~12月龄＞50次/min；新生儿~2月龄＞60次/min；2）神志改变：反应迟钝、嗜睡、躁动、惊厥等；3）严重呕吐、腹泻，出现脱水表现；4）少尿：儿童尿量＜0.8 mL/（kg·h），或每日尿量婴幼儿＜200 mL/m^2,学龄前儿童＜300 mL/m^2,学龄儿童＜400mL/m^2，14岁以上儿童＜17 mL/h,或出现急性肾衰竭；5）合并肺炎；6）原有基础疾病明显加重；7）需住院治疗的其他临床情况。

1.3　中医辨证

风热犯卫证：发病初期，发热或未发热，咽红不适，轻咳少痰，口干；舌质边尖红，苔薄或薄腻，脉浮数，或指纹浮紫[1]。

表寒里热证：恶寒，高热，头痛，身体酸痛，咽痛，鼻塞，流涕，口渴，便秘；舌质红，苔薄或黄，脉数，或指纹浮红或紫滞[1]。

湿遏卫气证：低热起伏、热势缠绵，头身困重、恶心或呕吐，汗出不畅、倦怠、纳呆、腹痛、便溏不爽（大便黏）、口干不欲饮；舌苔厚腻、脉濡数，或指纹紫滞[3]。

邪犯胃肠证：发热，咽部不适，脘腹胀痛，或恶心，或呕吐，或大便稀，倦怠乏力；舌红，苔厚腻，脉滑数，或指纹紫滞[4]。

痰热蕴肺证：高热，气促，烦躁不安，痰黄黏稠，口渴喜饮，咽痛，目赤；舌质红，苔黄或腻，脉滑数，或指纹紫滞[1]。

毒热壅肺证：高热不退，神昏谵语，萎靡，咳嗽，气喘，少痰或无痰，便秘腹胀；舌质红绛，苔黄或腻，脉弦滑数，或指纹紫滞显于气关或命关[1]。

肺脾气虚证：轻微咳嗽，汗多，语声低微，纳差，脘腹满闷不舒，倦怠乏力，伴或不伴低热；舌淡红，脉虚或细缓，或指纹淡紫或淡红[5]。

1.4　实验室检查

流感的实验室检查包括血常规检查、血生化、脑脊液、影像学和病原学检测等，其具体检测项目及对应指标变化可参照《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》[1]。

1.5　鉴别诊断[1-2]

1.5.1　普通感冒　流感的发热程度较普通感冒高，全身症状比普通感冒重，且可能出现头痛、肌肉酸痛、乏力等全身症状，以及肺炎、心肌炎等并发症，而普通感冒较少出现全身症状，并发症也较为罕见；追踪流行病学史有助于二者的鉴别；普通感冒的流感病原学检测阴性，或可找到相应的病原学证据。

1.5.2　新型冠状病毒（SARS-CoV-2）感染　感染早期一般表现为发热、乏力、干咳，多数患儿症状在1周内消失。少数患儿发病后1周病情加重，出现呼吸困难、呼吸窘迫、休克等，伴/不伴发热。部分儿童、小婴儿及新生儿感染后症状可不典型，表现为呕吐、腹泻等消化道症状或仅表现为反应差、呼吸急促。其临床表现与流感相似，SARS-CoV-2感染流行病学史是早期识别和鉴别诊断的重要依据，SARS-CoV-2核酸和抗体检测可帮助明确诊断。

参考文献

[1]国家卫生健康委办公厅，国家中医药管理局办公室．流行性感冒诊疗方案（2020年版）[J]．中国病毒病杂志，2021，11(1)：1-5.

[2]国家呼吸系统疾病临床医学研究中心，中华医学会儿科学分会呼吸学组．儿童流感诊断与治疗专家共识（2020年版）[J]．中华实用儿科临床杂志，2020，35(17)：1281-1288.

[3]王雪峰，尚云晓．儿童流行性感冒中西医结合防治专家共识[J]．中国中西医结合儿科学，2021，13(5)：369-374.

[4]尹贵蕾．基于德尔菲法的儿童流行性感冒中医证候分类及临床分布特征初探[D]．天津：天津中医药大学，2020.

[5]李芹，陈志斌．福建省中医药防治流行性感冒专家共识（2022年版）[J]．福建中医药，2022，53(8)：1-3.